

כאבי בטן (Abdominal Pain)

אין תלונות רבות שהן אתגר קליני כמו כאבי בטן (כאבים אבדומינליים, abdominal pain). האבחנה המבדלת לכאבי בטן היא גדולה מאוד, אולי הרחבה ביותר בעולם הרפואה. יש בבטן מבנים אנטומיים רבים: שרירים, כלי דם גדולים, דרכי עיכול, כבד, לבלב, כליות, דרכי שתן ואיברי מין. כל אחד מהם עלול להיות המקור לכאבי בטן. חשוב לעשות אנמנזה מקיפה לכאבים אלו ולהקפיד על בדיקה פיזיקלית מדוקדקת. מטרת ההערכה היא לזהות **בטן כירורגית (בטן חריפה, בטן אקוטית)**. מרבית כאבי הבטן נובעים ממקור שפיר, אך כ-10% מן המטופלים שנבדקים במלר"ד (מחלקה לרפואה דחופה, חדר מיון) בשל כאבי בטן סובלים מפתולוגיה מסכנת חיים.

יש הפרעה אידיופתית הנקראת מיגרנה בטנית (eniargim lanimodba) זו תופעה המופיעה לרוב רק בילדים, והיא מתבטאת בהתקפים של כאבי בטן. למטופלים האלה יש כאבי בטן קשים שנמשכים 2-27 שעות, מלווים בבחילות, הקאות, חיוורון והיעדר תיאבון. בין ההתקפים מטופלים אלה אסימפטומטיים לחלוטין, והם אינם סובלים ממחלות אחרות.

דגשים באבחנה

אופי הכאב

כאב מפושט ועמום מעיד על מקור ויסצרלי לכאבים (כלומר מאיברי הבטן עצמם). לעיתים קרובות תחילה יופיעו כאבים עמומים, ועם הזמן הכאבים יתמקמו באזור ספציפי. לדוגמה: אפנדיציטיס (דלקת התוספתן). ככל שהכאב שטחי יותר הוא יהיה חד, נקודתי ודוקר יותר.

הופעת הכאבים

הופעה פתאומית של כאבי בטן חריפים מעידה על קרע באיבר, אירוע וסקולרי או ספאזם של דרכי השתן או דרכי המרה. כאבים המופיעים במהירות מחשידים לסטרנגולציה של המעי (חסימת מעיים) או לפנקריאטיטיס (דלקת הבלב, pancreatitis).

מקום הכאב

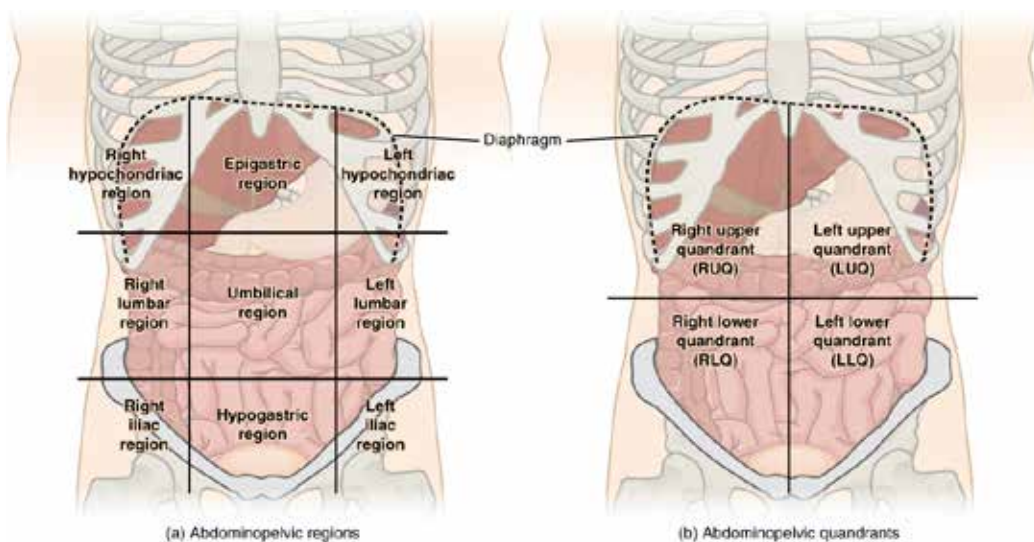
מקום הכאב הוא פרט אנמנסטי (אבחנתי) חשוב ביותר. נהוג לחלק את הבטן בשתי תצורות, לרבעים ולריבועים (ראו טבלה 19.2). כאבים אפיגסטריים (בבטן עליונה) מעידים על גורם מן הקיבה או מהתריסריון. גורמים מהבלב מתייצגים באזור הבטן העליונה. כאבים מן המעי הדק הם בדרך כלל דיפוזיים וקשה למקמם, אך בדרך כלל הם יהיו פריאומביליקליים (סביב הטבור). כאבים שנובעים מהתוספתן נוטים להתחיל ככאבים ויסצראליים עמומים באזור פריאומביליקלי, ובהמשך לנוע לכיוון הבטן הימנית התחתונה. כאב המקרין לכתף נובע מגירוי דלקתי שבו מעורבת הסרעפת. כאבים ביליאריים (שמקורם מדרכי המרה) מקרינים לסקפולה הימנית ולאפיגסטריים השמאלי. כאבים ביליאריים יכולים לעיתים להתייצג ככאבים אנגינטיים.

מין וגיל

בנשים בגיל פוריות יש לתשאל בנוגע למחזור הווסת ולפעילות המינית. כמו כן יש לתשאל על הפרשות מסריחות מן הנרתיק (מעיד על PID). כל כאב חריג בנשים בגיל פוריות מחשיד בראש ובראשונה להיריון אקטופי.

רמזים לבטן חריפה

חום, הקאות (בייחוד הקאות דמיות), סינקופה, שלשולים דמיים, בטן קשה, סימני גירוי צפקי (פריטוניאלי).



איור 19.1 מבנה מערכת העיכול

(מזכה: 3@48cd014a756b-f835af-b005-8a17e4cnx.org/contents/ for free at <http://cnx.org/contents/17e4eeaa-8a005-45af-b835-f756a014cd48@3>)

דגשים בבדיקה פיזיקלית

1. מתחילים את הבדיקה הפיזיקלית בסקירה כללית של המטופל, כולל ABC, התרשמות מכאבים, נינוחות ומנח הגוף של המטופל; רגליים כפופות מעידות על בטן כירורגית.
2. בכל מקרה של כאבים בבטן בודקים את הבטן בדגש על ראייה (inspection) ומישוש (palpation).
3. נוכחות של המטומות בבטן מעיד על בטן כירורגית. המטומה באזור הפריאומביליקלי (סביב הטבור) נקראת **סינדרום על שם גריי טרנר** (Grey Turner's sign) המטומה באזור לומברי נקראת **סינדרום על שם קאלן** (Cullen's sign). סימנים אלו מעידים על דימום רטרופריטוניאלי.*
4. בודקים נוכחות של **סימני גירוי צפיקים (פריטוניאליים)**.

תמונה 19.1 המטומה בבטן

(A) המטומה באזור הפריאומביליקלי (סביב הטבור) נקראת **סינדרום על שם גריי טרנר** (Grey Turner's sign).

(B) המטומה באזור לומברי נקראת **סינדרום על שם קאלן** (Cullen's sign).

(מזכה: Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk, CC BY 2.0 <http://cnx.org/content/m14942/latest/>)



* רטרופריטונאום הוא האזור שמאחורי קרום הצפק (הפריטונאום) ובו נמצאים הכליות, שלפוחית השתן, חלק מן התריסרון, המעי הגס, הבלב וקשירי למפה רבים.

סימני גירוי צפיקים, פריטוניאליים (Peritonism, Peritoneal irritation)

הפריטוניאום (קרום הצפק) הוא קרום העוטף את איברי הבטן. כאשר איברי הבטן נפגעים הקרום נוטה לעבור תהליך דלקתי שמתבטא בכאבים חזקים. נוכחות של סימנים אלו קובעת למעשה אם יש בטן אקוטית. שני הסימנים על כך הם ריבאונד (rebound) וגארדינג (guarding).

- גארדינג (guarding) לא רצוני - בבדיקה פיזיקלית הבטן אמורה להיות רכה. כאשר יש תגובת התנגדות למישוש הבטן, למשל כאשר שרירי הבטן מתקשים בהתנגדות למישוש, המצב נקרא גארדינג (או דיפנס, Défense Musculaire). גארדינג רצוני נוטה להיעלם בעת נשימה עמוקה או בתמרונים אחרים. גארדינג שאינו רצוני מעיד על גירוי צפיקי, ולכן מעיד על בטן כיורוגית. מצב זה גם נקרא **בטן קשה**.
- ריבאונד, רַתַּע (rebound) - בעת הבדיקה יש ללחוץ על הבטן באיטיות, ולשחרר במהירות. אם כאב נוצר או מוחמר בשחרור - הבדיקה חיובית. ריבאונד מופיע בעקבות התזזה המהירה של הפריטוניאום המודלק, ולכן יש כאב.



תמונה 19.2 המטומה באזור הפריאומביליקלי
נקראת סינדרום על שם גריי טרנר (Grey
Turner's sign)



תמונה 19.3 המטומה באזור לומברי נקראת
סינדרום על שם קאלן (Cullen's sign)

(מזכרה: Herbert L. Fred, MD and Hendrik A.
van Dijk, [http://cnx.org/content/m14904/
\(latest/, CC BY 2.0](http://cnx.org/content/m14904/latest/)

טבלה 19.2 אבחנה מובדלת לכאבי בטן לפי מקום הכאב

רביע שמאלי עליון (LUQ)		רביע ימין עליון (RUQ)
• קרע בטחול • כיב פפטי • פנקריאטיטיס • אנגינה פקטוריס		• כוליציסטיטיס (דלקת של כיס המרה) • פנקריאטיטיס • הפטיטיס • פנאומוניה • אנגינה פקטוריס
	• פריאומביליקלי (סביב הטבור)	
	• חסימת מעיים • אפנדיציטיס בשלב מוקדם • פנקריאטיטיס • דיסקציה של האאורטה הבטנית • אירוע וסקולרי מזנטרי • אורמיה (uremia)	
רביע שמאלי תחתון (LLQ)		רביע ימין תחתון (RLQ)
• דיברטיקוליטיס • PID • הריון חוץ־רחמי (אקטופי) • אבנים בדרכי שתן • סטרנגולציה של בקע מפשעתי		• אפנדיציטיס • PID • הריון חוץ־רחמי (אקטופי) • אבנים בדרכי שתן • סטרנגולציה של בקע מפשעתי • דיברטיקוליטיס

טיפול

טיפול טרום־בית חולים בכאבי בטן הוא משני בחשיבותו, שכן יש צורך לזהות את האטיולוגיה, שהיא לעיתים קרובות כירורגית. יש לשים דגש על הערכת ABC, על ביצוע אנמנזה מדוקדקת, על בדיקה פיזיקלית ועל שלילת אטיולוגיה קרדיאלית או נשימתית.

הודעה מוקדמת לבית החולים

יש להודיע לבית החולים במקרים האלה:

- סכנה ברורה לנתיב אוויר בשל ירידה ברמת ההכרה ובשל הקאות
- מצוקה נשימתית מכל סיבה
- אטיולוגיה קרדיאלית
- סימני בטן חריפה: חום, סינקופה, סימני גירוי צפקיים (פריטוניאליים)

טיפול אנלגטי בכאבי בטן

בשנת 1957 פרסם רופא ושמו זכרי קופ (Sir Zachary Cope) נייר עמדה אשר לפיו מתן אנלגטיקה בכאבי בטן חריפים מעוות את הבדיקה הפיזיקלית ופוגע ביכולת האבחון של הקלינאי. עם השנים בוצעו כמה מחקרים שהפריכו טענה זו, ובשנת 2011 פורסמה סקירת קוקרן (Cochrane) הוא מאגר מידע מבוסס ראיות ברפואה) על שמונה מחקרים בנושא. הפרקטיקה היום יומית משתנה לאט, וגם כיום יש קלינאים שפועלים על פי אמונה תפלה זו. למען הסר ספק, **אין לעכב משככי כאבים אצל מטופל עם כאבי בטן אקוטיים.**

טיפול בכאבי בטן עם דימום ב־GI

מטופלים שסובלים מדימום חריף בדרכי העיכול (מתבטא בהקאה או בשלשולים עם דם אדום ובוהק) עלולים להידרדר למצב של הלם המורגי. במטופלים אלה יש לטפל על פי עקרונות ה־PHTLS (pre-hospital trauma life support), לפי הקטגוריה של דימום בלתי נשלט. יש לתת נוזלים בזריות, לפי גישת permissive hypotension - שבה יש להגביל את מתן הנוזלים במצב של הלם המורגי בעקבות טראומה, כלומר יש לשמור על לחץ דם סיסטולי סביב 90 מ"מ כ"ס.

מטופלים עם הקאות בצורת קפה טחון (coffee ground) כלומר הקאות בצבע שחור כמו קפה, בדרך כלל לא מציינים סימני הלם המורגי בשטח, אך יש לשמור על עירנות וזהירות אם יש הקאות כאלה.

ניהול נתיב אוויר במטופל מקיא

מטופלים מקיאים הם מטופלים שנתיב האוויר שלהם אינו שמור. אם לחץ הדם מאפשר זאת, יש לפנות את המטופלים המקיאים בשיבה. כאשר לחץ הדם נמוך במיוחד יש להשכיב את המטופלים על הצד. אם מבוצעת אינטובציה יש להקפיד על הכללים האלה:

- מיגון מלא, כולל מסכה, מגן פנים, כפפות וחלוק
- הכנת שני סקשנים במקביל
- הרמת המטופל לתנוחה של 45 מעלות

הימנעות מאכילה ושתייה, צום (Nil Per Os: NPO)

כל מטופל שמלין על כאבי בטן חריפים וחריגים, גם ללא סימני גירוי פריטוניאליים ברורים, צריך להימנע מאכילה ושתייה, כלומר אסורה הכנסת מזון ושתייה דרך הפה (משמעות הביטוי הלטיני בתרגום לאנגלית היא: nothing by mouth). מטופלים אלו צריכים להפסיק לצרוך מזון ושתייה עד שכירורג ינחה שמתר.

כאבי צד, כאבים לומבריים (Flank Pain)

כאבים לומבריים (נקראים גם flank pains) אקוטיים בדרך כלל מסווגים לפי שלוש קטגוריות אטיולוגיות:

- כאבים ממקור שאינו כלייתי
- כאבים ממקור תוך־כלייתי
- כאבים בגלל ניקוז פתולוגי של שתן